

表 1 痰の外観と原因疾患

喀痰の性状	色 調	主な疾患
膿性	黄色	かぜ症候群 細菌性肺炎 気管支拡張症 慢性気管支炎 副鼻腔気管支症候群 急性副鼻腔炎 肺膿瘍（悪臭を伴う、やや褐色調） ABPA
	緑色	気管支拡張症、慢性気管支炎、DPBなどで緑膿菌定着状態
	オレンジ色	レジオネラ
	鉄さび色	肺炎球菌肺炎
	莓ゼリー状	クレブシエラ
	黒色・褐色	真菌
漿液性	透明～白色 （特に泡沫を交えた卵白様の漿液性痰が大量に出るものはbronchopleuralと呼ばれる）	ARDS 気管支喘息 浸潤性粘液腺癌
粘液性	透明～白色	かぜ症候群 気管支喘息 COPD（感染を伴わない場合） 副鼻腔気管支症候群（感染を伴わない場合）
泡沫状	ピンク色	肺水腫
血痰ないし 喀血	血液が付着した状態から血液そのものまで種々	気管支拡張症 非結核性抗酸菌症 肺結核 肺癌 肺アスペルギルス症 肺梗塞 Goodpasture 症候群 血管炎症候群の肺病変 肺動静脈奇形

への沈下が痰として喀出される場合もある。

診 断

a 病 歴

患者の中には口腔内や咽頭にたまった唾液を吐き出すことも「痰」と表現する場合があるため、咳により喀出されるものかを確認する。

痰の性状（粘性か漿液性か膿性か、色調、曳糸性の有無など）や量、持続期間、随伴症状（発熱、呼吸困難、喘鳴、胸痛、嚥下障害、鼻閉・鼻漏の有無）、並存疾患（心疾患、アレルギー、鼻・副鼻腔疾患、歯科疾患の有無）、喫煙歴は必ず聴取する。

b 身体所見

胸部診察では、痰の喀出が多い気管支拡張症や肺炎では coarse crackles を聴取する。COPD やびまん性汎細気管支炎（DPB）、喘息に伴う痰では、wheezes や rhonchi とともに種々の程度の coarse crackles を聴取する。

視診では樽状胸郭、胸鎖乳突筋の緊張亢進、Hoover 徴候など COPD を示唆する所見の有無に注意する。

鼻症状（鼻閉・鼻漏）を有する患者では副鼻腔の叩打痛や咽頭後壁の後鼻漏の付着もチェックする。

表 2 Geckler 分類による喀痰 Gram 染色の品質評価

群	細胞数/1 視野	
	扁平上皮細胞	白血球
1	>25	<10
2	>25	10~25
3	>25	>25
4	10~25	>25
5	<10	>25
6	<25	<25

[Geckler RW, et al: J Clin Microbiol 6: 396, 1977 より引用]

c 検 査

痰を有する患者に対する検査としては、痰そのものを検体とする検査と、患者に対する検査がある。

i) 喀痰検査

まず肉眼的の外観で漿液性、粘液性、膿性、泡沫性、さらに血痰・喀血に分類する。これらの肉眼的性状を呈する代表的な疾患を表 1 に示す。肉眼的性状の評価には Miller & Jones の分類が用いられる（M1：唾液、完全な粘液性痰、M2：粘液の中に膿性部分が少量含まれる、P1：膿が全体の 1/3 以下、P2：膿が全体の 1/3～2/3、P3：膿が全体の 2/3 以上）。P3 が最も質が高く、P2、P1、M2、M1 の順に品質が落ちる。